

Fecha Última Actualización: 17-02-2022 14:55:16

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Juan Carlos Campos Aburto
Edad : 68a 5m 25d
Dirección : Irrazaval 0208

Rut : 6.286.912-7
Fecha Nacto: 23/08/1953
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1938471
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 8494 8147

N° Epicrisis
291722

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Emergencia Adulto

Fecha Ingreso : 02/01/2022 22:17

Días Estadía : 46

Unidad de Egreso : Medicina Básica (2do Piso)

Fecha Egreso : 17/02/2022 09:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Anamensis remota

- Antecedentes médicos: Demencia con variante conductual de demencia frontotemporal (Enfermedad de Pick)
- Antecedentes quirúrgicos: no conocidos
- Medicamentos: Ácido Valproico, sertralina, quetiapina
- Alergias: no conocidas

Historia de ingreso

Paciente con antecedentes descritos, consulta en urgencia el 02/01 por dolor y distensión abdominal, sin fiebre u otros síntomas. A su ingreso en regulares condiciones, taquicárdico y con livideces hasta abdomen, en exámenes destaca parámetros inflamatorios elevados (GB 15.630; PCR 344) y función renal alterada (crea 1.86; BUN 54) asociado a hipoperfusión clínica y de laboratorio con lactato en 40. TAC AP que informa apendicitis aguda perforada en flanco - hipocondrio derecho, con burbujas de gas extraluminales periapendiculares asociado a íleo adinámico.

Evolucionó con un paro cardio-respiratorio presenciado con actividad eléctrica sin pulso que retorna a circulación espontánea posterior a 18 min de reanimación cardiopulmonar, manejo avanzado de la vía aérea, requerimientos de adrenalina, 1 matraz de Bicarbonato y 2 ampollas de Gluconato de Calcio, desfibrilación por taquicardia ventricular sin pulso con posterior descarga con 270 J y salida a fibrilación auricular.

Tras esto pasó a pabellón, se describen los siguientes hallazgos en protocolo operatorio: Apendicitis aguda perforada, Peritonitis estercoracea de cuatro cuadrantes, íleo adinámico, con distensión de asas, Broncoaspiración. En pabellón se realizó lavado de peritoneo y apendicectomía (sin sufrimiento de asas). Laparostomizado con bolsa de Bogotá. Se trasladó a recuperación en malas condiciones, hemodinamia inestable, con noradrenalina 0.4 ug/kg/min, VMI por TOT, SDRA severo y retención de CO2 hasta 130, evolucionó desfavorablemente con falla renal, falla hepática leve y PAFI hasta 86, por lo que se inició BNM y manejo antibiótico con ampicilina/ Sulbactam. Evolucionó con DVA a la baja hasta suspensión con mejoría de la microhemodinamia clínica y de laboratorio con aclaramiento de lactato y PaFi al alza hasta 218 con suspensión de BNM, en relación al medio interno con mejoría de creatinina y diuresis aproximada de 1 ml/kg/hr.

Se conversó con familiares quienes comprenden la situación del paciente y acuerdan revisión de laparostomía frente a mejoría clínica. Re ingresó a pabellón el 05/01 por equipo de UTU (Dr. Ottolino), encontrándose escaso líquido turbio en relación a muñón apendicular sin signos de perforación. Se realizó adherenciólisis roma, con lesión incidental de aprox 1 cm en segmento IVb de hígado logrando hemostasia con surgicell. Se instaló dispositivo Abthera y VAC. Con salida laparostomizado a UPC.

Diagnosticos de ingreso a la unidad

Fecha Epicrisis : 17/02/2022 14:55

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 17-02-2022 14:55:16

Página 2 de 3

- Shock séptico de foco abdominal con falla orgánica múltiple
- Peritonitis generalizada de cuatro cuadrantes secundaria a apendicitis aguda perforada
 - 02/01: Laparotomía exploratoria y limpieza de cavidad peritoneal con cierre con bolsa de Bogotá
 - 05/01 Revisión de laparotomía. Instalación de dispositivo Abthera y VAC
- Falla respiratoria / SDRA
- Falla hemodinámica
- Falla renal aguda AKIN III
- Paro cardiorespiratorio recuperado: 18 min de reanimación (AESP -- TVSP -- FA)
- Antecedentes

Evolución durante la estadía:

Quirúrgico: A su ingreso a UPC laparostomizado con VAC y Abthera. Re ingresó a pabellón el 09/01 para cierre de cavidad abdominal. Como intercurrentes se aisló E. coli MS en cultivo peritoneal y desarrollo de seroma en porción proximal de herida operatoria. Se mantuvo en seguimiento por equipo quirúrgico, evolucionó sin necesidad de reintervenciones, sin drenajes, de alta desde el punto de vista quirúrgico.

Hemodinamia: Requirió noradrenalina a dosis bajas durante estadía en UPC en contexto de sedación y depleción de volumen con BH negativos, ya suspendidas al momento del traslado. A la fecha con episodios de hipertensión y taquicardia que se asocian a taquipnea (obs disautonomías) manejado con Dexmedetomidina.

Respiratorio: A su ingreso cursó con SDRA severo, requirió VMI protectora y BNM que se mantuvo hasta el 19/01 (sin pronó). VMI prolongada en contexto de patología quirúrgica e intercurrentes infecciosas. Se realizó TQT percutánea el 27/01 sin incidentes, con disminución progresiva de soporte ventilatorio. Presentó un tromboembolismo pulmonar agudo segmentario derecho, sin repercusión hemodinámica asociada.

Neurológico: A su ingreso a UPC sin claridad de funcionalidad previa. Día 06/01 se controló TAC de cerebro donde no destacan lesiones agudas. Se suspendió sedación el 21/01 logrando vigilia espontánea pero sin lograr conectarse al medio. EEG muestra signos de encefalopatía hipóxico isquémica. En este contexto se decide de forma multidisciplinaria en conjunto a neurología, jefaturas de UPC y de módulo; proporcionalización de manejo.

Infeccioso: Cursó con shock séptico de foco abdominal secundario a apendicitis aguda perforada y peritonitis generalizada. Inicialmente manejado con Ampicilina Sulbactam. Se rescató cultivos de líquido peritoneal intraoperatorios positivos para E. coli resistente, por lo que se escaló a Imipenem. En contexto de fiebre se pancultivó objetivando bacteriemia por S. haemolyticus MR por lo que se agregó Vancomicina. Posteriormente, dada limitación del esfuerzo terapéutico se determinó no innovar en cultivos ni terapia antimicrobiana.

Medio interno: En contexto de shock séptico y falla multiorgánica cursó con insuficiencia renal aguda KDIGO III. Evolucionó sin necesidad de terapia de reemplazo renal, con diuresis restituida y Crea a la baja.

Dada condición neurológica de paciente, se definió por equipo tratante de UPC junto a neurología, manejo conservador: no RCP, no VMI. Conversado con familiares de paciente. Se trasladó a unidad de menor complejidad.

Evolución sala básica

Durante su estadía evolucionó en malas condiciones, en coma, GCS 7. Afebril, hemodinamicamente estable, sin requerimientos de O2 adicional. Evaluado por equipo de cuidados paliativos:

- TQT disfuncional, no candidato cambio de TQT. Manejo con escopolamina y morfina, atropina SL si secreciones de difícil manejo.
- BDZ por horario para sedación y Haloperidol en caso de agitación.
- Se suspendió nutrición enteral dado TQT con cuff disfuncional.
- Antipiréticos SOS. No iniciar ATB, no cultivar.
- Aceptado por clínica familia, se rotó a tratamiento subcutáneo.

Diagnósticos de egreso:

1. Encefalopatía hipóxico isquémica - Estado de mínima conciencia
- PCR recuperado (18 min)
 - Demencia con variante conductual de demencia frontotemporal (Enfermedad de Pick) avanzada

Fecha Epicrisis : 17/02/2022 14:55

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 17-02-2022 14:55:16

Página 3 de 3

2. Shock séptico de foco abdominal recuperado
 - Apendicitis aguda perforada
 - 02/01 Laparotomía exploradora y aseo, egresa con bolsa de Bogotá
 - 05/01 Revisión de laparotomía e instalación de Abthera y VAC
 - 09/01 Laparotomía y cierre de cavidad peritoneal
3. Falla orgánica múltiple recuperada
 - SDRA severo recuperado
 - Falla renal aguda KDIGO 3, sin TRR, recuperada
4. TEP segmentario derecho sin anticoagulación 17/01
5. Bacteriemia por *S. haemolytus* MR tratada

Diagnóstico de Egreso

Encefalopatía hipóxico-isquémica -
Paro cardiorrespiratorio recuperado -
Shock séptico de foco abdominal recuperado - Apendicitis perforada + peritonitis secundaria, operada
Traqueostomía percutánea con cuff disfuncional -

Condición de Egreso Alta Derivado al Extrasistema

Egreso con Catéter Doble J: NO

Estable, sin O2 por TQT. Cuff disfuncional, no candidato a cambio de TQT.

Plan Post Alta

Reposo cabecera 35°
Régimen cero, agua para comfort
Aseo bucal cada 6 hrs
O2 para Sat > 92%
Aspiración de secreciones por KNT
Bromuro ipatropio 2 puff cada 6 hrs por TQT
Haloperidol 2.5 mg cada 12 hrs SC
Haloperidol 2.5 mg SC SOS si agitación.
Morfina 16 mg cada 4 hrs SC
Escopolamina 10 mg cada 8 hrs SC
Traslado a clínica familia

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Karol Joyce Villalobos Gallardo
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 17/02/2022 14:55

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:54

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar